PROTOCOLLO 34

Mobilizzazione dopo chirurgia dell'ATM

Recuperare progressivamente la mobilità secondo le indicazioni del chirurgo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Post chirurgica	Post chirurgico	6 a 8 minuti	2 o 3 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Post artrocentesi o artroscopia
- ✓ Ipomobilità post chirurgica
- ✓ Paziente inviato dal chirurgo maxillofacciale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Assenza del nulla osta del chirurgo
- ! Segni di infezione della ferita
- ! Dolore in rapido aumento
- ! Parestesie nuove del volto

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo



Accordo
Verifica tempi e limiti indicati dal chirurgo.



Fase iniziale
Movimenti attivi assistiti nel range consentito.



Mobilizzazione
Distrazione delicata di grado I e II.



Progressione
Aumenta il range secondo la guarigione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I e II nelle prime settimane
Esercizio	ogni 2 o 3 ore da sveglio
Verifica	contatto con il chirurgo

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Il protocollo del chirurgo ha la priorità
- ✓ Monitora gonfiore e dolore
- ✓ Documenta i progressi

Errori da evitare

- ! Anticipare i tempi chirurgici
- ! Ignorare segni di infezione
- ! Mobilizzazioni intense precoci

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Movimento frequente	Aperture attive lente nel range consentito	10 ripetizioni ogni 2 o 3 ore

! **Nota clinica.** Nel post chirurgico la comunicazione con il chirurgo è parte integrante del protocollo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.